

POLIMIALGIA REUMÁTICA

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La polimialgia reumática (PMR) es un trastorno inflamatorio de etiología desconocida, caracterizado por dolor y rigidez matutina que afecta a las cinturas escapular y pelviana y a la región cervical. Es más frecuente por encima de los 50 años y sobre todo, en las mujeres.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es eminentemente CLÍNICO

Los síntomas suelen tener una aparición rápida, en pocos días e incluso, de forma brusca durante la noche. Es muy característico que estos pacientes tengan dificultad para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Puede comenzar de forma unilateral, pero conforme avanza la enfermedad, es frecuente que se haga bilateral.

- Dolor:
 - Inflamatorio.
 - Peor al levantarse y mejora parcialmente a lo largo del día.
 - Suele afectar a cuello, cintura escapular, cintura pélvica, caderas y muslos.
- Rigidez
 - Matutina.
 - Duración entre 30-60 minutos.
- Otros
 - Febrícula.
 - Fatiga.
 - Síndrome general (astenia, anorexia y pérdida de peso).

Exploración física

Restricción al movimiento activo de las cinturas escapular y pelviana sin inflamación articular clínicamente observable. El movimiento pasivo es, en la mayoría de las ocasiones, prácticamente normal.

Pruebas complementarias

- Bioquímica: Valorar reactantes de fase aguda, sobre todo la PCR, que suele encontrarse elevada.
- Hemograma: Valorar VSG que suele presentar valores >40 mmHg.
- Ecografía: Para valorar bursitis subacromial y tenosinovitis bicipital si dolor en cintura escapular y bursitis trocantérica si dolor en cintura pelviana.
- RMN: Indicada en PMR con presentación atípica o pacientes con reactantes de fase aguda normales.

En general, la mejor forma de diagnosticar una PMR en Urgencias sería una clínica compatible junto con marcadores de fase aguda elevados (PCR y VSG). Éstos últimos también son útiles para el seguimiento, dado que suelen elevarse en caso de recaídas.

Criterios de clasificación

Criterios imprescindibles	Criterios opcionales
Edad $\geq$ 50 años.	Rigidez matutina $>$ 45 minutos (2 puntos)
Omalgia bilateral.	Dolor o limitación en cintura pelviana (1 punto)
Aumento de PCR.	Ausencia de FR y/o Ac Antipéptido citrulinado (2 puntos)
Aumento de VSG.	Ausencia de dolor en articulaciones periféricas (1 punto)

Una puntuación $>$ 4 puntos es diagnóstico de PMR.

Podríamos considerar también datos ecográficos, que valorarían la presencia de inflamación en estructuras de la cintura escapular y pelviana (de forma unilateral y bilateral) añadiendo un punto por cada una de las dos formas y considerándose diagnóstico si a la tabla anterior junto con las alteraciones ecográficas se obtuviera una puntuación $>$ 5.

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente.
- Refractoriedad al tratamiento habitual.
- En caso de duda diagnóstica.

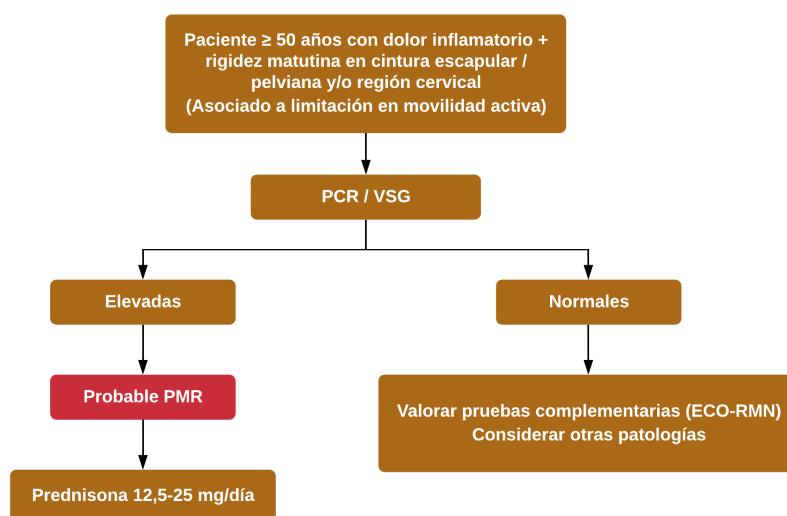
TRATAMIENTO

De elección **glucocorticoides** como:

- Prednisona a dosis inicial de 12,5-25 mg/día.

Los pacientes suelen presentar una mejoría espectacular en la primera semana de tratamiento e incluso muchos, en las primeras 24 horas. Después de 3-4 semanas de tratamiento, se recomienda iniciar pauta descendente a ritmo de 2,5 mg cada dos semanas hasta 10 mg/día y posteriormente, descenderemos 1-1,25 mg/mes hasta suprimir el tratamiento que suele necesitarse durante al menos 1-2 años. En algunos casos, hemos de mantener dosis bajas de corticoide de manera indefinida (2,5-5 mg/día) para evitar las recaídas.

NOTA



Algoritmo resumen de actitud ante PMR.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Gay Matecón, M.A. Arteritis de células gigantes. Polimialgia reumática. Arteritis de Takayasu. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018. 88: 522- 530.
- García Arias, R.L. Martín Gutierrez, J. Claudia Díaz, M.Fernández-Avila, D. Polimialgia reumática. Revista Colombiana Reumatología. 2015. 22: 104-109.